

So wirken Medikamente auf die Mundhöhle

Serie – Gesund im Mund Trockener Mund, brennende Schleimhäute, steigendes Kariesrisiko – viele Medikamente beeinflussen die Mundgesundheit. Erfahren Sie in Folge 3, inwiefern besonders pflegebedürftige Menschen, die oft mehrere Arzneimittel gleichzeitig einnehmen, davon betroffen sind.

P flegebedürftige Menschen sind häufig von Polypharmazie betroffen. Dies kann zu zahlreichen Nebenwirkungen führen, die ebenfalls die Mundhöhle betreffen. Besonders problematisch ist die Mundtrockenheit (Xerostomie), eine häufige Begleiterscheinung vieler Arzneimittel. Ein reduzierter Speichelfluss erhöht das Risiko für Karies, Parodontitis und Infektionen, da Speichel eine schützende Funktion für Zähne und Schleimhäute hat. Zudem kann es zu Mundschleimhautveränderungen, Schluckbeschwerden und Prothesenproblemen kommen. Welche Medikamente haben welche Auswirkungen?

Auswirkungen von Medikamentengruppen auf die Mundhöhle

Viele systemische Arzneimittel beeinflussen die orale Gesundheit direkt oder indirekt, indem sie physiologische Prozesse wie Speichelfluss, Knochenstoffwechsel oder Immunreaktionen verändern.

Antihypertensiva: Blutdrucksenkende Medikamente wie ACE-Hemmer, Betablocker und Kalziumkanalblocker können Mundtrockenheit und Gingivahyperplasie (Zahnfleischwucherung) verursachen. ACE-Hemmer rufen mitunter ein brennendes Gefühl im Mund und Geschmacksstörungen hervor. Kalziumkanalblocker

sind mit einer verstärkten Zahnfleischwucherung assoziiert. Diuretika reduzieren die Speichelproduktion und fördern somit Karies und Pilzinfektionen.

Zytostatika und Immunsuppressiva: Krebspatienten, die eine Chemotherapie erhalten, leiden oft unter starken oralen Nebenwirkungen. Zytostatika verursachen Mukositis, Ulzerationen und eine erhöhte Infektionsanfälligkeit. Immunsuppressiva können zu einer vermehrten Zahnfleischwucherung und Parodontitis führen.

Bisphosphonate: Diese Medikamente, die u.a. zur Behandlung von Osteoporose und Knochenmetastasen sowie Tumoren der Brustdrüsen und der Prostata eingesetzt werden, stehen in Verbindung mit der medikamentenassoziierten Osteonekrose. Dabei kommt es zu einer gestörten Wundheilung nach zahnärztlichen Eingriffen.

Antidepressiva und Psychopharmaka: Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer erhöhen das Risiko für Mundtrockenheit und Parodontitis. Trizyklische Antidepressiva können zu einer starken Reduktion der Speichelsekretion führen. Neuroleptika sind mit einer erhöhten Kariesanfälligkeit und Speichelflussstörungen verbunden.



MEDIKAMENTENBEDINGTE NEBENWIRKUNGEN IN DER MUNDHÖHLE

Mundtrockenheit (Xerostomie): Xerostomie ist eine der häufigsten Nebenwirkungen und kann zu erhöhter Kariesanfälligkeit, Mundgeruch und Schleimhautentzündungen führen.

Gingivahyperplasie: Einige Medikamente wie beispielsweise Kalziumkanalblocker, die Wirkstoffe Ciclosporin und Phenytoin führen zu einer übermäßigen Zahnfleischvergrößerung. Dies erschwert die Mundhygiene und erhöht das Risiko für Parodontitis.

Medikamenteninduzierte Kiefernekrose: Bisphosphonate und einige monoklonale Antikörper können zu einer schwer-

wiegenden Osteonekrose des Kiefers führen. Betroffene Patienten zeigen nicht heilende Wunden nach Zahnextraktionen, die von Schmerzen und intensivem Geruch begleitet werden.

Geschmacksstörungen (Dysgeusie): ACE-Hemmer, Metronidazol und einige Chemotherapeutika können Geschmacksveränderungen hervorrufen, darunter metallischer oder bitterer Geschmack.

Orale Ulzerationen und Schleimhautveränderungen: Zytostatika und bestimmte Antibiotika können Schleimhautentzündungen, Aften oder Ulzerationen verursachen.



GESUND IM MUND

Die folgenden Themen finden Sie in dieser Serie:

- So wichtig ist Zahnpflege im Alter
- Folgen unzureichender Mundhygiene
- Medikamente und ihre Auswirkungen auf den Mund
- Reinigungstipps und Pflegeprodukte
- Nahrungsergänzungsmittel

Antibiotika und Antimykotika: Antibiotika können das orale Mikrobiom beeinflussen. Breitbandantibiotika können Dysbiosen hervorrufen und das Risiko für orale Candidiasis erhöhen. Tetracycline führen zu Zahnverfärbungen, insbesondere bei Kindern, deren Zähne sich noch in der Entwicklung befinden.

Ursachen der Mundtrockenheit – Xerostomie

Die Ursachen reichen von natürlichen Altersveränderungen über Medikamentennebenwirkungen bis hin zu systemischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder neurologischen Störungen. Speichel spielt eine essenzielle Rolle für die orale Gesundheit. Er schützt die Zähne vor Karies, unterstützt die Mundschleimhaut bei der Regeneration, erleichtert das Kauen und Schlucken und enthält antimikrobielle Komponenten. Ein Mangel an Speichel kann schwerwiegende Folgen haben, insbesondere für Menschen, die in ihrer Mundhygiene eingeschränkt oder auf Hilfe angewiesen sind.

Zu den Medikamenten, die eine Xerostomie verursachen können, gehören unter anderem Antihypertensiva wie Diuretika, Betablocker oder ACE-Hemmer sowie Psychopharmaka wie Antidepressiva, Neuroleptika und Anxiolytika. Dazu kommen Analgetika, Opioide, Antihistaminika, Anticholinergika und Diabetesmedikamente. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Zusammensetzung des Speichels. Die Speichelproduktion nimmt ab, und die Funktion der Speicheldrüsen kann eingeschränkt sein. Auch eine schlechte Blutzuckereinstellung bei Diabetes mellitus kann die Speichelproduktion beeinträchtigen. Neurologische Erkrankungen wie Morbus Parkinson und Alzheimer können die Speichelsteuerung beeinträchtigen, was zu Mundtrockenheit oder sogar Hyper-salivation führt. Auch das Sjögren-Syndrom, eine Autoimmunerkrankung, greift die Speicheldrüsen an und führt zu starker Mundtrockenheit. Viele pflegebedürftige Menschen nehmen aufgrund von Schluckstörungen, Appetitlosigkeit oder kognitiven Einschränkungen zu wenig Flüssigkeit zu sich. Das kann die Speichelproduktion zusätzlich reduzieren. Krebspatienten, die eine Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich erhalten haben, erleiden oft eine irreversible Schädigung der Speicheldrüsen.

Die Folgen der Xerostomie

Speichel schützt die Zähne vor Säureangriffen, indem er den pH-Wert im Mund reguliert und remineralisierende Mineralien liefert. Ohne ausreichenden Speichel steigt das Risiko für Wurzelkaries,

besonders bei freiliegenden Zahnhälsen und einer schnell voranschreitenden Karies, vor allem bei einer unzureichenden Mundhygiene. Mundtrockenheit begünstigt zudem Entzündungen und Infektionen der Mundschleimhaut. Das kann zu Schleimhautirritationen und schmerzhaften Läsionen in der Mundhöhle führen. Hier handelt es sich häufig um:

- Candidiasis: Hefepilzinfektionen treten häufig bei geschwächtem Immunsystem auf.
 - Aphten und Ulzerationen: Schmerzhafte Entzündungen und Wunden an den Schleimhäuten der Mundhöhle
 - Schluck- und Kauprobleme: Speichel ist wichtig für die Zerkleinerung und das Gleiten der Nahrung. Ohne ausreichend Speichel kann es zur Dysphagie und Mangelernährung kommen. Ebenfalls besteht Erstickengefahr.
 - Geschmacksveränderungen: Xerostomie kann den Geschmackssinn beeinträchtigen, wodurch betroffene Personen weniger Appetit haben und ihre Nahrungsaufnahme sinkt.
 - Mundgeruch (Halitosis): Ein trockener Mund begünstigt das Wachstum von geruchsbildenden Bakterien, dies führt zu unangenehmem Mundgeruch.
 - Schwierigkeiten mit herausnehmbarem Zahnersatz: Durch fehlenden Speichel, der als Gleitmittel dient, kann es zum einen zu Haftproblemen bei Prothesen und ebenfalls zu schmerzhaften Druckstellen kommen.
 - Prothesenstomatitis: Entzündungen unter Prothesen durch unzureichende Befeuchtung der Mundschleimhaut
- Medikamente sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen Medizin, können jedoch Nebenwirkungen auf verschiedene Körpersysteme haben, einschließlich der Mundhöhle. Betroffen sind hier Mundschleimhaut, Zähne und der Zahnhalteapparat. ►►

PFLEGE EINFACH MACHEN

Zahlreiche Medikamente beeinflussen die Mundgesundheit und können schwerwiegende Symptome verursachen.

Die Mundtrockenheit ist ein häufig anzutreffendes Problem bei pflegebedürftigen und älteren Menschen. Dies kann zu Folgen für die orale und allgemeine Gesundheit führen.

Besonders das erhöhte Risiko für Karies, Infektionen und Schluckbeschwerden erfordert eine gezielte Prävention und regelmäßige zahnmedizinische Betreuung.

Schlüsselwörter: Polypharmazie, Mundtrockenheit, Mundschleimhaut, Speichelfluss



Juliane Petring

Dentalhygienikerin & Präventionsmanagerin B.Sc.
Sportparkstr. 42, 85560 Ebersberg
juliane.petring@kabelmail.de